

**Documento para guiar la toma de decisiones e implementación de
UNA SESIÓN ÚNICA DE APOYO EN SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL (SMAPS)**
Carmen Martínez Viciano, Referente de Salud Mental, Departamento Médico, MSF-OCBA 2011

ÍNDICE:

1. Introducción
2. Histórico sobre Sesiones Únicas
3. Intervenciones de Apoyo en Salud Mental y Psicosocial en contextos de violencia, catástrofes o abandono social
4. Criterios para el uso pertinente de una Sesión Única de Salud Mental y Psicosocial
5. Desarrollo de una Sesión Única de Salud Mental y Psicosocial
6. Midiendo los resultados terapéuticos
7. Puntos clave que hay que recordar
8. Referencias, Recursos & Herramientas

1. Introducción

Las sesiones únicas de Apoyo en Salud Mental y psicosocial, informalmente denominadas intervenciones “de efecto inmediato¹”, han sido motivo de una gran polémica dentro de MSF así como para otros actores humanitarios.

Es de gran importancia entender el origen de esta estrategia terapéutica/de apoyo, y esto se asocia a los problemas a los que a diario nos enfrentamos en los diversos contextos en los que trabajamos, donde la posibilidad de hacer un seguimiento óptimo de comunidades y pacientes no siempre es una opción realista.

En las intervenciones de salud mental y psicosociales nunca se recomendaría como primera opción el diseño de estrategias basadas en una sesión única, excepto para Primeros Auxilios Psicológicos. Por el contrario, siempre será deseable intentar ofrecer la posibilidad de seguimiento a las personas que padecen algún trastorno psicológico, a menos que no se considere necesario. Sin embargo, las limitaciones a las que nos enfrentamos en nuestro trabajo diario en el terreno no nos permiten asegurar este seguimiento esperado. Estas limitaciones están principalmente relacionadas con el contexto y la seguridad así como también con otros aspectos individuales de los pacientes.

Las intervenciones de una sola consulta de salud mental y psicosocial consisten en una estrategia terapéutica adaptada a esas situaciones en las que con casi total probabilidad no habrá posibilidad de ver de nuevo a los pacientes a medio plazo (2-3 meses). La estrategia tiene como objetivo permitir una intervención de apoyo profesional básica, minimizando al máximo la exposición a factores de riesgo. “No dañar” seguiría siendo un principio fundamental como en el resto de intervenciones humanitarias aplicado ahora a las intervenciones de salud mental y psicosociales.

Aunque el término “sesión única” implicaría la limitación de la duración del tratamiento a una sola consulta, en realidad lo que siempre se espera es encontrar la posibilidad de hacer más de una sesión, si fuese necesario. Esto significa que la estrategia basada en una sesión única nos ayuda a centrarnos en la intervención para cerrar los problemas planteados al final de esa sesión, por si se tratase de la última., sin dejar cuestiones abiertas que no pudieran abordarse totalmente durante la consulta. Sin embargo, el paciente podría ser visto, al menos eso es lo que sería deseable, por el mismo psicoterapeuta o consejero y por tanto revisarse los problemas trabajados o cuestiones que se consideren de mayor importancia en la actualidad.

¹ En inglés “One shot”

Las intervenciones de salud mental y psicosociales de sesión única pueden ser utilizadas por todo el personal de apoyo en salud mental y psicosocial que trabaje en el terreno y se dedique a prestar apoyo de forma individualizada (psicólogos, psicoterapéuticos, consejeros comunitarios, consejeros profesionales, etc.). Los aspectos clínicos y la profundidad de la intervención variarán de acuerdo con la primera evaluación rápida individual, las aptitudes y experiencia profesional y el foco específico del proyecto.

2. Histórico sobre Sesiones Únicas

Las intervenciones consistentes en una sesión única son una estrategia específica creada para esos contextos en los que no esté asegurado poder hacer un seguimiento de los pacientes. No se trata de una forma de *debriefing* ni de una intervención tras la exposición a un incidente traumático, u otras intervenciones clínicas ya puestas en marcha en el pasado en entornos de crisis. Sin embargo, tampoco se trata de una estrategia clínica muy innovadora, si no que es más bien una compilación de las mejores prácticas acumuladas en el terreno, basándose claramente en diferentes modelos y escuelas psicoterapéuticas y muy enfocada a modelos centrados en el problema, en las soluciones y en la potenciación de factores de resiliencia y de protección.

En situaciones en las que las personas que acaban de sufrir incidentes críticos o dolorosos, la estrategia recomendada seguiría siendo los Primeros Auxilios Psicológicos, que no requieren profesionales de salud mental y psicosocial sino que bastaría con personas formadas específicamente en esta clase de apoyo. Los Primeros Auxilios Psicológicos es una respuesta humana y de apoyo a otro ser humano que sufre y que puede necesitar apoyo en situaciones de crisis². La principal diferencia entre las intervenciones consistentes en una sesión única y los primeros auxilios psicológicos es el tiempo transcurrido entre la consulta y la exposición al incidente estresante (muy recientemente para los primeros auxilios y no para una sesión única). De todas formas, en el terreno también vemos a pacientes que no necesariamente han vivido incidentes o crisis recientes, sino que presentan sufrimiento psicológico y carecen de acceso regular a servicios de Apoyo en Salud Mental y psicosocial. En muchos de los contextos en los que trabaja MSF, y principalmente con enfoques basados en clínicas móviles, reconocemos la alta probabilidad de tratar a pacientes una sola vez. El aporte de primeros auxilios psicológicos no sería el mejor enfoque si las personas no se encuentran en una situación de post crisis, aunque en ocasiones algunas personas de todas formas necesiten SMAPS. Por consiguiente, las intervenciones de sesión única constituyen la alternativa a los primeros auxilios psicológicos para personas que sufren pero que no se encuentran necesariamente en una situación de post crisis y que con casi total probabilidad no tendrán la posibilidad de beneficiarse de un seguimiento. De todas formas, los casos más difíciles deberían referirse a los servicios médicos, incluidos los de atención a la salud mental, siempre que sea posible, lo que desgraciadamente no suele ocurrir.

Diferentes estudios han demostrado los efectos negativos de algunos tratamientos psicológicos. Por ejemplo, algunos estudios han encontrado que en función del punto de partida de la terapia una vez que ha aparecido el estado de angustia, tratamientos psicológicos beneficiosos ayudan a mejorar las tasas de recuperación en relación a las personas que no han recibido tratamiento alguno; tratamientos psicológicos perjudiciales (o tratamientos psicológicos que causan efectos negativos) interfieren con el proceso natural de recuperación, lo que significa que los pacientes siguen presentado una elevada tasa de trastornos mentales tras el tratamiento en relación a las personas que no han recibido tratamiento. Éste parece ser el patrón frecuente en terapias identificadas como perjudiciales^{3 4} y los meta-análisis (análisis de todos los resultados fiables disponibles para el tratamiento, incluyendo los ensayos aleatorios controlados) han encontrado este patrón en tratamientos conocidos como perjudiciales, como por ejemplo *debriefings* de

² World Health Organization (2011). Psychological First Aid: Field Guide (Pre-Final Version). Ginebra.

³ Lilienfeld, S.O. (2007). Psychological treatments that cause harm. Perspectives on Psychological Science, 2, 53–70

⁴ Mohr, D.C. (1995). Negative outcome in psychotherapy: A critical review. Clinical Psychology: Science and Practice, 2, 1–27

sesión única en casos de trauma^{5 6} (donde a los pacientes se les anima a que descarguen sus emociones en los días o meses posteriores al incidente). Los ensayos aleatorios controlados^{7 8} también han encontrado este patrón en psicoterapias expresivas y experienciales (que se centran en la descarga de emociones potentes). En tratamientos psicológicos perjudiciales, los pacientes mejoran, pero más despacio de lo normal.

Estos estudios se basan en algunos tratamientos psicoterapéuticos específicos tales como *debriefings* psicológicos u otros iniciados al aparecer altos índices de sufrimiento, y parece haberse acordado no recomendar estas intervenciones. El enfoque basado en una sesión única tiene en cuenta las lecciones aprendidas de intervenciones que no han funcionado.

Existen evidencias desde un buen principio de que la terapia de sesión única podría ser útil en el tratamiento de niños y adolescentes. Un ensayo randomizado controlado reciente⁹ demostró que, tras un accidente de tráfico, una sesión única de tratamiento estructurado sirviéndose de psico-educación y de la reconstrucción del accidente mediante dibujos y juegos asociados al accidente resultaba muy útil para que niños preadolescentes redujesen problemas conductuales y estados depresivos. Estudios que investigaban la terapia de sesión única en niños y adolescentes con problemas de salud mental encontraron mejoras al mes¹⁰ y a los 18 meses de haberse recibido el tratamiento.¹¹

En adultos, un ensayo aleatorio controlado demostró los beneficios de las terapias cognitivas conductuales de sesión única para los supervivientes del terremoto en Turquía¹², aunque el tratamiento evitó la descripción del incidente o la descarga emocional. Otros tratamientos de sesión única han demostrado beneficios para los adultos; de nuevo, todos evitan las descripciones o las descargas emocionales, pero de todas formas éstos no le sirven a MSF porque bien requieren ordenadores^{13 14} o son para problemas de adicción.^{15 16}

El estudio de MSF-OCBA “Evaluación de los resultados de una intervención psicoterapéutica de sesión única en poblaciones afectadas por el conflicto armado interno en Colombia”¹⁷ sólo posibilitó volver a contactar a

⁵ Rose R, Bisson J, Wessley S. Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Review, The Cochrane Library, 2002

⁶ Van Emmerik AAP, Kamphuis JH, Hulsbosch AM, Emmelkamp PMG. Single-session debriefing after psychological trauma: A meta-analysis. *Lancet* 360:766-771, 2002

⁷ Beutler, L.E., Frank, M., Schieber, S.C., Calvert, S., & Gaines, J. (1984). Comparative effects of group psychotherapies in a short term inpatient setting: An experience with deterioration effects. *Psychiatry*, 44, 67-76.

⁸ Mohr, D.C., Beutler, L.E., Shoham-Salomon, V., Bergan, J., Kaszniak, A.W., Yost, E.B., & Engle, D. (1990). Identification of patients at risk for non-response and negative outcome in psychotherapy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 58, 622-628

⁹ Zehnder D, Meuli M, Landolt MA. Effectiveness of a single-session early psychological intervention for children after road traffic accidents: a randomised controlled trial. *Child Adolesc Psychiatry Ment Health*. 2010 Feb 8;4:7.

¹⁰ Perkins R. The effectiveness of one session of therapy using a single-session therapy approach for children and adolescents with mental health problems. *Psychol Psychother*. 2006 Junio;79(Pt 2):215-27.

¹¹ Perkins R, Scarlett G. The effectiveness of single session therapy in child and adolescent mental health. Part 2: an 18-month follow-up study. *Psychol Psychother*. 2008 Junop;81(Pt 2):143-56.

¹² Başoğlu M, Salcioğlu E, Livanou M, Kalender D, Acar G. Single-session behavioral treatment of earthquake-related posttraumatic stress disorder: a randomized waiting list controlled trial. *J Trauma Stress*. 2005 Feb;18(1):1-11.

¹³ Amir N, Bomyea J, Beard C. The effect of single-session interpretation modification on attention bias in socially anxious individuals. *J Anxiety Disord*. 2010 Marzo;24(2):178-82.

¹⁴ Amir N, Weber G, Beard C, Bomyea J, Taylor CT. The effect of a single-session attention modification program on response to a public-speaking challenge in socially anxious individuals. *J Abnorm Psychol*. 2008 Nov;117(4):860-8

¹⁵ Diskin KM, Hodgins DC. A randomized controlled trial of a single session motivational intervention for concerned gamblers. *Behav Res Ther*. 2009 Mayo;47(5):382-8.

¹⁶ Lau-Barraco C, Dunn ME. Evaluation of a single-session expectancy challenge intervention to reduce alcohol use among college students. *Psychol Addict Behav*. 2008 Junio;22(2):168-75.

¹⁷ Urrego, Z., Abaakouk, Z., Román, C. & Contreras, R. (2009). Evaluation of results from a single-session psychotherapeutic intervention in population affected by the Colombian internal conflict. Final Report of Research. (disponible en castellano)

un número reducido de casos, lo que no permitió hacer generalizaciones respecto a la utilidad de las sesiones únicas. El efecto de no poder ver de nuevo a los pacientes una segunda vez confirma (aunque ese no era el objetivo del estudio) el hecho que únicamente resulta viable realizar una sola consulta en muchas circunstancias, y que por lo tanto, la estrategia es imprescindible. Sin embargo, la evaluación cuantitativa de los casos re-contactados para valoración del efecto mediato de la sesión única permitió establecer que era útil para solucionar, por lo menos parcial o completamente, los síntomas motivo de la consulta inicial.

3. Intervenciones de Apoyo en Salud Mental y Psicosocial (SMAPS) en contextos de violencia, abandono social o catástrofes

Entre los contextos y prioridades operacionales en los que interviene MSF, la violencia crónica o aguda extrema como conflictos armados, violencia organizada, violencia urbana o el uso indiscriminado de tipos específicos de violencia, como la Violencia Sexual y de Género, conforman la mayoría de nuestros escenarios de trabajo. Asociado a la violencia, las poblaciones huyen debido a la inestabilidad en sus lugares de origen: desplazados y refugiados claramente son poblaciones vulnerables a quienes hay que proporcionar asistencia médico-humanitaria.

En los últimos años, las poblaciones de riesgo ocasionadas por la discriminación o abandono social, tales como migrantes y otros grupos olvidados también han constituido uno de nuestros focos de atención.

Además de las catástrofes provocadas por la mano del hombre, los desastres naturales con un claro impacto en la salud de la población generalmente requieren ayuda humanitaria. En estas situaciones las actividades con un enfoque psicosocial son una de las elecciones más significativas, y para identificar a las personas que, por presentar un sufrimiento más agudo, necesitan apoyo durante la primera fase de la emergencia, el aporte de primeros auxilios psicológicos sería la primera acción recomendada.

Otros escenarios en los que MSF podría decidir intervenir con un componente de SMAPS, como por ejemplo algunas epidemias concretas como las causadas por enfermedades estrechamente asociadas a la muerte (fiebres hemorrágicas, VIH/sida, TB, etc.), programas nutricionales o intervenciones vinculadas a la salud reproductiva u otras en principio no requerirían el uso de sesiones únicas.

Las sesiones únicas están diseñadas para esos pacientes con necesidades específicas de apoyo individual (referirse al capítulo 4 más abajo), complementando a otras actividades de grupo como la psico-educación, e intervenciones psicosociales comunitarias u otras muy recomendadas para las comunidades afectadas.

En términos generales, tal como se ha mencionado anteriormente, en las primeras fases después de situaciones de crisis o estresantes, el apoyo individual se priorizaría en forma de primeros auxilios psicológicos, mientras que para otras situaciones en las que las personas presentan sufrimiento psicológico y necesitan apoyo, las intervenciones psicológicas y de consejería estarán indicadas y, sólo si la probabilidad de seguimiento es baja, se proporcionarán sesiones únicas.

4. Criterios para el uso pertinente de Sesión Única de Salud Mental y Psicosocial

La sesión única sólo se utilizará en determinadas situaciones cuando ninguna otra intervención de apoyo individual recomendada se ajuste a la realidad.

Los principales criterios para decidir el uso de las sesiones únicas son los siguientes:

1. Factores Contextuales: esos más ligados a aspectos externos al paciente y de su entorno. Ejemplos:
 - a) Población Flotante,
 - b) La persona ha vivido múltiples desplazamientos en el pasado,

- c) La persona está considerando el desplazamiento,
 - d) La persona está trabajando en la agricultura, la recolección o la tala o suele trasladarse de una granja/terra a otra,
 - e) El paciente vive en alguna otra parte que no es el lugar donde se realiza la intervención y el transporte no es fácil.
 - f) Las fuerzas de seguridad y la policía pueden limitar la provisión de servicios de SMAPS, por ejemplo, en centros de detención
2. Factores Organizativos (MSF): Seguridad y otras limitaciones que impedirían o dificultarían nuestra presencia en un futuro próximo (2 ó 3 meses). Ejemplos:
- a) Baja frecuencia programada de clínicas móviles u otras estrategias fijas; sólo se considerará el seguimiento para casos severos si no hay otras opciones como las referencias, y no se dan la mayoría de factores,
 - b) Alta probabilidad de ser la última intervención en la zona geográfica,
 - c) Alta posibilidad de contar con los mismos profesionales la próxima vez que el paciente sea objeto de seguimiento.
3. Factores Individuales y/o Rasgos de Personalidad: Aspectos internos de la persona que estamos tratando que implicarían una baja probabilidad de acudir a una segunda sesión. Ejemplos
- a) Bajo nivel de compromiso (evaluado por medio de ejemplos de la vida diaria durante la sesión),
 - b) Evidencia de abandono anterior de otros tratamientos (por ejemplo, tratamiento médico),
 - c) La persona demuestra poco convencimiento o credibilidad en el apoyo psicológico o consejería,
 - d) La razón de la consulta es muy específica, apropiada para una consejería, y fácilmente abordable durante una sesión única.

5. Desarrollo de una Sesión Única de SMAPS

Siguiendo las consideraciones mencionadas anteriormente y los criterios para esta intervención específica, es importante recalcar que la decisión de utilizar sesiones únicas idealmente debería ocurrir durante la primera fase de la sesión. Esto implica que en los escenarios donde posiblemente se recomendase la estrategia, antes deberá hacerse un análisis de los criterios organizativos; y la evaluación de los factores contextuales e individuales deberá hacerse al principio del encuentro con la persona en cuestión. Por consiguiente, el uso de la estrategia empieza desde un buen principio y no se trata de una decisión post sesión que será muy arriesgada para la salud de la persona.

También podría suceder que el personal de SMAPS hubiese puesto en marcha una intervención de apoyo psicológico o consejería (con la voluntad de empezar un proceso por ejemplo de psicoterapia breve o consejería breve durante algunas sesiones) y después de algún tiempo se percatase de que seguramente no podrá efectuarse un seguimiento. En este caso, deberá hacerse un rápido análisis de la situación para minimizar los riesgos. Si la sesión puede reconducirse hacia una sesión única, ésta probablemente será la mejor opción. Sin embargo, el objetivo más importante será trabajar cuestiones sensibles ya “abiertas” y centrarse en intentar encontrar tantos recursos como sea posible para afrontar la situación.

Las siguientes fases de la sesión única puede que no tengan lugar en este orden concreto, exceptuando las dos primeras fases de evaluación.

Fases durante la sesión única:

- I. Primera evaluación asociada al motivo de la consulta: definición y encuadre del problema. Evaluación de los riesgos (auto lesión, agresividad, violencia, suicidio, etc.)
- II. Evaluación de los factores que determinarían si el uso de la sesión única es apropiado.
- III. Centrarse en el principal problema y preocupaciones que puedan abordarse durante la sesión. Facilitar la priorización de problemas /preocupaciones y centrarse en el/la principal.

Comprensión y Análisis del problema con otros problemas asociados (el alcance de la fase variará conforme a si abordar el problema principal es apropiado o no)

- IV. Expresión emocional solamente cuando la emita la propia persona de forma espontánea. Confortar y contener esas emociones.
- V. Normalización de reacciones y síntomas, cuando sea posible.
- VI. Movilización de la resiliencia y de aptitudes y recursos personales, familiares y sociales.
- VII. Psico-educación básica: Información general, recomendaciones y sugerencias adaptadas a cada caso.
- VIII. Acuerdos, referencias (si se requieren y si es posible) y Cierre

Algunos aspectos que hay que tener en cuenta durante las sesiones únicas:

- Los objetivos de la intervención siempre están vinculados a las expectativas de los pacientes y a las condiciones del contexto.
- En todos los casos, la mejora del estado del paciente y la prevención de los problemas más severos seguirán siendo las metas más importantes.
- La primera evaluación debería hacerse en múltiples niveles e incluir a otros actores implicados en el problema y la solución de los niveles sociales y familiares.
- El problema elegido debería definirse con precisión y acordarse de forma mutua.
- Otros problemas identificados por el profesional sólo se explicarán si se considera constructivo; deberán evitarse las reacciones secundarias que no sea posible abordar. Sin embargo, si se recomienda más apoyo, esté deberá ser posible.
- La intervención deberá centrarse en posibilidades reales, en lugar de en situaciones ideales.
- El desarrollo deberá basarse en las particularidades de cada caso.
- Centrarse en el futuro en lugar de en el pasado.
- Reconocer que los cambios requieren reorganización y reestructuración de imágenes rígidas e inhibitoras que evitan afrontar de forma efectiva la realidad.
- Tener en cuenta la fase de desarrollo del caso y el ciclo de vida individual y familiar.
- Prever los posibles efectos positivos y negativos de la intervención en todo momento durante la sesión.
- Potenciar los recursos disponibles en el presente y explorar los que se retomen del pasado (que solían ser efectivos en fases más funcionales de la vida del paciente).
- Explorar recursos disponibles en las diferentes áreas y contextos de la persona, asociado a la solución o mejora del problema central; intentando activarlos, potenciarlos y optimizarlos.
- Proponer acciones directas e indirectas concretas que podrían ser hipotéticamente pertinentes para la solución del problema.

6. Midiendo los resultados terapéuticos

Medir los resultados terapéuticos en el terreno de la SMAPS siempre supone un desafío pues tenemos que considerar la parte subjetiva de medir el bienestar psicológico en los seres humanos. En el caso concreto de la sesión única, resulta incluso más difícil evaluar los resultados puesto que el marco para medir el cambio es demasiado limitado. De todas formas, consideramos que el uso de indicadores diversos y combinados nos permite reducir preferencias y obtener resultados más fiables.

Principalmente hay que considerar 3 tipos de indicadores, con los siguientes ejemplos:

A. Indicadores de actividad:

- Nº de nuevos pacientes detectados
- Nº total de sesiones únicas realizadas
- Tasa de Cobertura: Nº de pacientes que tienen acceso al servicio / prevalencia estimada conforme a un estudio exploratorio
- Accesibilidad: Nº de pacientes referidos del servicio médico / Nº de pacientes consultados

B. Indicadores de Eficiencia:

- Tasa de Cobertura de la población afectada (de acuerdo con los objetivos del proyecto)
- Tasa de Referencias: Nº de pacientes adecuadamente referidos a otros servicios y, tratados y con seguimiento, en consecuencia
- % de aceptación de la intervención consistente en una sesión única (por parte de la población diana, por parte del Ministerio de Sanidad y por parte del personal de MSF)
- * El indicador habitual de “Tasa de Seguimiento” no procede en este caso

C. Indicadores de Eficacia:

- % de mejora del estado psicológico de los pacientes al final de la sesión (este indicador puede dividirse en la mejoría de signos y síntomas y mejoría de la funcionalidad)

7. Puntos clave que hay que recordar

- La sesión única no es una intervención psicológica mágica ni extraordinaria que sustituiría procesos de psicoterapia o consejería. Al contrario, sólo se utiliza cuando limitaciones vinculadas a las organizaciones, factores contextuales o individuales hacen que establecer una estrategia multi sesiones sea imposible o improbable.
- Los primeros auxilios psicológicos siguen siendo la forma de intervención más recomendada en los casos de situaciones de post crisis para las personas individuales. Otras actividades en grupos deberían ser complementarias.
- Las sesiones únicas no implican que, cuando esté indicado terapéuticamente, se intente asegurar futuras sesiones.
- Siempre que sea posible se ofrecerá la posibilidad de prestar más apoyo en el futuro o referir de forma adecuada.
- La intervención se centra en el problema que se identifica como el motivo de la consulta. Sin embargo, es importante que se aborde adecuadamente sólo cuando sea viable analizarlo y abordarlo durante la sesión.
- La estrategia se abordará eventualmente como parte de los mecanismos de afrontamiento y la prevención de los problemas más graves.

8. Referencias, Recursos & Herramientas

- Comité Permanente inter Agencias (IASC por el inglés) (2007). Guías del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias, Ginebra
- MSF-Grupo de Trabajo Internacional (2009). Guía de Asesoramiento en Salud Mental
- MSF-OCBA-Misión Colombia (2006). Protocolo de atención clínica en Salud Mental
- MSF-OCBA-Misión Colombia (2009). Protocolo de consulta única y consejería en Salud Mental
- National Child Traumatic Stress Network & National Center for PTSD (2006, 2ª Edición). Psychological First Aid: Field Operations Guide
- National Institute of Mental Health (2002). Mental Health and mass violence: evidence-based early psychological intervention for victim/survivors of mass violence. A workshop to reach consensus on best practices. NIH Publications No 02-5138, Washington D.C; US Government printing office.
- World Health Organization (2011). Psychological First Aid: Field Guide (Versión Pre-Final)
- Urrego, Z., Abaakouk, Z., Román, C. & Contreras, R. (2009). Evaluación de resultados de intervenciones psicoterapéuticas de sesión única en población afectada por el conflicto interno colombiano. Informe Final del Estudio.
- SIS en Salud Mental versión 6: 2011. MSF-OCBA (para recogida de datos médicos en proyectos que integran salud mental)
- CD con Documentos & Herramientas relativas al Apoyo en Salud Mental y Psicosocial. MSF-OCBA (Versión May 2011)